

PERJANJIAN KERJASAMA**ANTARA****PT. DISA PRIMA MEDIKA****No:****Dengan****.....
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN****No:**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Sukorejo pada **Hari Jum’at Tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01/11/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk (ASURANSI MAG)**, berkantor pusat di The City Center Batavia Tower One Lt. 17 Jl. KH Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 87 tanggal 14 November 1980 yang dibuat dan dihadapan Haji Bebasda Daeng Lalo, SH notaris di Jakarta dan telah mendapat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A. 5/28/5 tanggal 29 Januari 1981, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Reza Putra S. IP** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Kepala Divisi Asuransi Kesehatan/GHS** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 200/HRD-MY/08/2019 yang ditandatangani oleh Direksi pada tanggal 1 Agustus 2019, dari dan oleh karena itu bertindak secara sah untuk dan atas nama PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk Menyusun perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan **Karyawan Bagi Peserta Program Kesehatan** dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**“Layanan Kesehatan”**).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha asuransi yang memiliki produk-produk asuransi diantaranya asuransi kesehatan yaitu **Magna Sehat**.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud menggunakan pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA** berupa fasilitas rawat inap dan rawat jalan bagi Tertanggung **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut Peserta).
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan pelayanan kesehatan berupa fasilitas rawat inap dan rawat jalan kepada Tertanggung **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Peserta Program Kesehatan adalah setiap karyawan dan anggota keluarganya yang dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan yang memiliki Kartu Peserta yang masih berlaku
- (2) Kartu Peserta adalah Kartu yang diterbitkan **PIHAK KEDUA** yang memuat identitas peserta program kesehatan
- (3) Kartu berobat adalah kartu yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berisi data pasien dan nomor medical record dan untuk pembuatannya tidak dikenakan biaya
- (4) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA** maupun di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pasien Umum, ialah dimana peserta karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku telah kehilangan haknya mengikuti fasilitas ini, sehingga peserta tersebut diperlakukan seperti pasien pasien lain pada umumnya dimana peserta tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu semua biaya yang terjadi
- (6) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu.
- (7) Rawat Jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap.

- (8) Rawat Gigi adalah konsultasi, pemeriksaan gigi dan tindakan medis yang dibutuhkan sehubungan dengan kondisi atau penyakit gigi bagi peserta program kesehatan
- (9) One Day Surgery adalah suatu Tindakan medis yang diberikan **PIHAK PERTAMA** guna memulihkan kesehatan dan atau keadaan tertentu dari Peserta **PIHAK KEDUA** yang membutuhkan tindakan pembedahan ringan atau sedang yang tidak memerlukan perawatan inap
- (10) Tindakan Medis, ialah semua tindakan yang diperlukan dan sesuai indikasi medis guna pemeliharaan kesehatan peserta
- (11) Penunjang Medis adalah semua jenis pemeriksaan dan pemberian obat-obatan yang diperlukan dan sesuai indikasi medis guna pemeliharaan kesehatan peserta
- (12) Pasien Cyto adalah Pasien yang dibawa ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi sakit atau cedera parah yang harus segera ditangani saat itu juga, karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (13) Layanan TPA Full Payor, ialah jasa pengelolaan penjaminan dan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan peserta **PIHAK KEDUA** oleh Pihak yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**
- (14) Layanan TPA Technology Only, ialah jasa pelayanan administrasi kesehatan dengan menggunakan sistem oleh Pihak yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memeriksa keabsahan dan memasukan data secara elektronik
- (15) Hari Kerja, ialah Pelayanan Operasional Claim **PIHAK KEDUA** dari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB tidak termasuk Hari Libur Nasional dan atau Cuti Bersama.
- (16) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Addendum, perubahan dan lampirannya

PASAL 2

LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan Kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama rujukan pelayanan kesehatan

PASAL 3

DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perusahaan Berbasis Risiko
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan dasar sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan, memberikan dan menjaga standart mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjalin Kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Pelayanan
 - 1.1. Ruang Lingkup Rawat Inap, yang terdiri dari:
 - 1.1.1. Rawat Inap dikelas sesuai dengan hak Peserta yang tercantum pada Kartu Peserta.
 - 1.1.2. Perawatan oleh dokter umum atau spesialis, jika dibutuhkan.
 - 1.1.3. Sarana penunjang Diagnostik yang sesuai dengan indikasi medis dan standard prosedur medis yang berlaku.
 - 1.1.4. Tindakan dengan alat-alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan medis.
 - 1.1.5. Obat-obatan yang tetap berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau Daftar Obat Generik atau obat lainnya jika dibutuhkan atau tidak tersedianya bentuk Generik.
 - 1.2. Ruang Lingkup Rawat Jalan, yang terdiri dari:
 - 1.2.1. Konsultasi/Tindakan Dokter Umum atau Dokter Spesialis.
 - 1.2.2. Sarana penunjang Diagnostik yang sesuai dengan indikasi medis dan standard prosedur medis yang berlaku.
 - 1.2.3. Tindakan dengan alat-alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan medis.
 - 1.2.4. Obat-obatan yang tetap berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau Daftar Obat Generik atau obat lainnya jika dibutuhkan atau tidak tersedia dalam bentuk Generik dan telah terdaftar pada Dirjen POM Indonesia.
 - 1.3. Ruang Lingkup *One Day Surgery* (ODS), yang terdiri dari:
 - 1.3.1. Adanya tindakan pembedahan berupa sayatan yang meliputi semua jasa bedah, jasa dokter, dan pemberian obat-obatan, alat bantu bedah dan jasa penunjang lainnya.
 - 1.3.2. Pemberian tindakan pembedahan dapat selesai hanya dalam 1 (satu) hari sesuai anjuran dokter, dengan tanpa dikenakan biaya kamar perawatan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tiga) tahun sejak tanggal 1 November 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2029 *meskipun Perjanjian ini ditandatangani sebelum atau sesudahnya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun berikutnya*

- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala **setiap 3 Bulan** sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di KEDUA BELAH PIHAK;
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, salah satu Pihak akan memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak lainnya dan apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender pihak yang menerima pemberitahuan perpanjangan dimaksud tidak memberikan jawaban tertulis atas pemberitahuan perpanjangan maka Perpanjangan Perjanjian akan berlaku secara otomatis sampai disepakatinya Perjanjian Kerjasama yang baru.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien tertanggung **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan informasi nama petugas contact person dari **PIHAK KEDUA** yang dapat dihubungi oleh **PIHAK PERTAMA** sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan konfirmasi mendadak (Cyto) atau persetujuan tertulis.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Melayani pasien tertanggung dari **PIHAK KEDUA** dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan tingkat pelayanan yang sama, baik pasien tertanggung dengan status OB BPJS maupun Status Mandiri;
 - b. Memberikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar harga atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dan akan segera memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila terjadi perubahan harga atau tarif;
 - c. Mengirimkan tagihan setiap bulan serta dokumen pelengkap (kwitansi, hasil penunjang, Resume medik) yang telah diberikan kepada pasien tertanggung pada bulan tersebut;
 - d. Memeriksa kartu karyawan tertanggung atau kartu identitas lain yang digunakan untuk verifikasi kebenaran data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila dirasa perlu **PIHAK PERTAMA** dapat langsung menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk konfirmasi;
 - e. Segera memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien tertanggung sesuai Surat Jaminan / Surat Garansi penuh;
 - f. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi mengenai ketersediaan kamar dan apabila ketersediaan kamar masih penuh / kosong, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan edukasi dan informasi kepada penanggung jawab pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan / Surat Garansi

- g. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dan pasien bertanggung jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien bertanggung sudah tersedia.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- Pasien bertanggung dari **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini (dapat dilayani atau diproses untuk pelayanan kesehatan dengan kelengkapan administrasi yang akan dilengkapi pada saat bersamaan atau paralel);
- Menerima pemberitahuan daftar atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** dan segera menerima pemberitahuan apabila terjadi perubahan harga atau tarif yang dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tarif baru diberlakukan;
- Menerima daftar perincian tagihan **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien bertanggung setelah pasien lepas rawat.
- PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan layanan mobil ambulance apabila pasien tersebut Rawat Inap.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- Membayar biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien bertanggung **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam perjanjian ini;
- Memberikan nama petugas penjamin (*contact person*) atau HRD yang dapat dihubungi sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan waktu konfirmasi mendadak (*cyto*) atau persetujuan tindakan;
- Menyampaikan Surat Jaminan / Surat Garansi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pasien bertanggung dari **PIHAK KEDUA** menggunakan jasa pelayanan pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kaidah.
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

PASAL 9 PROSEDUR

1. Prosedur Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Inap:

- 1.1. Peserta datang dengan menunjukkan Kartu Peserta yang masih berlaku serta Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Surat Rujukan dari dokter umum atau spesialis. Bilamana ada peserta yang datang dalam keadaan darurat tanpa membawa Kartu Peserta atau Surat Pengantar Rawat, maka **PIHAK**

- PERTAMA** diminta segera melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan status kepesertaan yang bersangkutan dan meminta Surat Pengantar Rawat untuk perawatan lebih lanjut dari yang bersangkutan.
- 1.2. **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program Kesehatan wajib untuk memberikan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** antara lain dalam hal:
 - a) Konfirmasi awal, dilakukan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam apabila ada Peserta Program Kesehatan yang memperoleh fasilitas Rawat Inap.
 - b) Melakukan pengisian dan mengirimkan Laporan Medis Awal beserta dengan Hasil Pemeriksaan Penunjang paling lambat 1 x 24 jam sejak konfirmasi awal dilakukan.
 - c) Melakukan pengisian dan mengirimkan kembali Konsul Medis Lanjutan (apabila diperlukan) paling lambat 1 x 24 jam sejak Konsul Medis Lanjutan diterima.
 - d) Konfirmasi selama perawatan, meliputi konfirmasi tindakan, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e) Konfirmasi akhir, pada saat perawatan Peserta Program Kesehatan berakhir.
 - 1.3. Jika peserta dirawat pada hari libur, **PIHAK PERTAMA** akan melaporkan melalui *Call Center* **PIHAK KEDUA** atau pada hari kerja berikutnya.
 - 1.4. **PIHAK PERTAMA** membebaskan peserta dari kewajiban pembayaran uang muka yang timbul dari Pelayanan Kesehatan yang diberikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
 - 1.5. Apabila peserta, atas keinginannya sendiri mengambil kamar yang lebih tinggi dari haknya, maka fasilitas ini juga otomatis akan gugur dan peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum dimana seluruh biaya yang timbul sejak awal perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan pasien.
 - 1.6. Apabila kamar yang menjadi hak peserta penuh dan atau karena keadaan penyakitnya, maka peserta yang bersangkutan akan ditempatkan sementara di kamar yang lebih rendah / tinggi dan fasilitas ini dapat terus berjalan dengan catatan ketika kamar yang menjadi haknya tersedia peserta wajib kembali atau dipindahkan ke kamar yang sesuai dengan haknya. Jika peserta tidak bersedia maka peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum dimana seluruh biaya yang timbul sejak awal perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan pasien.
 - 1.7. Untuk pemeriksaan / pemberian obat-obatan yang harganya di atas Rp300.000,00 per item **PIHAK PERTAMA** diharapkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pertanggungannya.
 - 1.8. Untuk pemeriksaan / Tindakan medis di luar kondisi CITO yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA** / dilakukan dengan persetujuan peserta dan atau keluarga saja maka penjaminannya akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - 1.9. Dalam setiap pelayanan, daftar penyakit / tindakan yang tidak bisa ditanggung akan menjadi tanggung jawab peserta di Rumah Sakit dan tidak bisa ditagihkan kecuali sudah ada permintaan dari **PIHAK KEDUA** untuk langsung menagihkan seluruh biaya ke **PIHAK KEDUA**.

Seperti disebutkan dibawah ini daftar Penyakit / Tindakan / Perawatan / Kondisi yang tidak bisa ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**:

- (1) Perawatan Inap yang tidak diperlukan / tidak berindikasi medis.
- (2) Rawat Inap yang semata-mata ditujukan hanya untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium / Pemeriksaan penunjang termasuk untuk *check up* atau perawatan inap untuk melakukan *Physiotherapy* saja.
- (3) Tindakan / Pemeriksaan yang bersifat *screening* dan tidak mutlak diperlukan dalam terapi.
- (4) Tindakan pemeriksaan dan atau terapi / obat-obatan yang tidak berindikasi medis.
- (5) Terapi / obat-obatan yang diberikan pada saat pasien pulang dalam jumlah yang berlebihan (tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari saat pasien keluar Rumah Sakit).
- (6) Tindakan / Perawatan yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, perawatan yang tidak memiliki Surat Pengantar Rawat atau kartu telah '*expired*' atau tidak berlaku lagi.
- (7) Segala sesuatu yang diminta oleh pasien namun tidak berhubungan dengan terapi atau segala sesuatu yang bersifat personal misalnya makanan tambahan, telpon, koran, *tissue*, perlengkapan mandi, *laundry*, dsb.

2. Prosedur Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Jalan:

- 2.1. Peserta wajib menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku dan kartu Idenditas (KTP), apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta maka peserta akan diberlakukan sebagai Pasien Umum dimana seluruh biaya yang timbul sejak awal perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan pasien.
- 2.2. **PIHAK PERTAMA** membebaskan peserta dari kewajiban pembayaran uang muka.
- 2.3. Untuk segala pemeriksaan Penunjang Fisioterapi dan Laboratorium termasuk pembelian obat-obatan, Peserta wajib membawa rujukan/resep yang diberikan oleh Dokter **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu
- 2.4. **PIHAK PERTAMA** diminta untuk memperhatikan batas penjaminan seperti yang tercantum di belakang kartu peserta atau struk pengesahan awal pada sistem.
- 2.5. Apabila biaya yang terjadi melebihi Faedah yang tercantum di dalam kartu atau struk pengesahan akhir pada sistem, maka kelebihan biaya tersebut wajib diselesaikan oleh peserta sebelum meninggalkan tempat.
- 2.6. Untuk pemeriksaan / pemberian obat-obatan yang harganya di atas Rp300.000,00 per item **PIHAK PERTAMA** diharapkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pertanggungannya.
- 2.7. Dalam setiap pelayanan, daftar penyakit / tindakan yang tidak bisa ditanggung akan menjadi tanggung jawab peserta di tempat dan tidak bisa ditagihkan kecuali sudah ada permintaan dari **PIHAK KEDUA** untuk langsung menagihkan seluruh biaya ke **PIHAK KEDUA**.

Seperti disebutkan di bawah ini daftar Penyakit/Tindakan/Perawatan/Kondisi yang tidak bisa ditanggung:

- a) Tindakan pemeriksaan dengan menunjukkan Kartu telah '*expired*'
- b) Tindakan / Perawatan yang tidak diperlukan/tidak berindikasi medis, tidak sesuai dengan diagnosa penyakit, yang bersifat *screening* dan yang tidak

Pihak I	Pihak II

- mutlak diperlukan dalam terapi.
- c) Terapi/obat-obatan yang tidak berindikasi medis; termasuk segala jenis vitamin, supplement, obat penenang, dan obat hormonal baik dengan maupun tanpa rekomendasi dokter untuk konsultasi rawat jalan.
 - d) Pemeriksaan Penunjang / Pembelian Obat-obatan tanpa melalui pemeriksaan Dokter dari Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** atau atas permintaan sendiri.
 - e) Peresepan obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas (OTC - *on the Counter*), yaitu obat-obatan golongan bebas dan bebas terbatas seperti minyak telon, balsem, betadin, dsb, serta obat herbal seperti diabet, kiranti, dsb, baik dengan maupun tanpa rekomendasi dokter.
 - f) Biaya Non Medis seperti biaya Kartu Berobat, Buku Panduan Kesehatan, *masker*, *underpad*, biaya fotokopi dan materai.
 - g) Perawatan yang bertujuan untuk estetika dan atau kosmetik.
 - h) Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau penyesuaian berat badan.
 - i) Penggunaan segala jenis alat bantu seperti alat bantu dengar, korset, dsb.
 - j) Segala sesuatu yang diminta oleh pasien namun tidak berhubungan dengan terapi atau segala sesuatu yang bersifat personal seperti *tissue*, termometer, pasta gigi, biaya makanan tambahan (termasuk susu dan bubur bayi), dsb.
 - k) Pemberian obat yang berlebihan baik dari sisi kegunaan maupun dari indikasinya.
 - l) Tindakan pencegahan termasuk segala bentuk imunisasi, vaksinasi, KB, dan kontrol hamil.
 - m) Biaya cek rutin kesehatan (*medical chek-up*).
3. Prosedur Pelayanan Kesehatan untuk ODS (*One Day Surgery*):
- 3.1. Peserta wajib menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku dan melampirkan Surat Pengantar Rawat kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian ini.
 - 3.2. **PIHAK PERTAMA** diminta segera melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan status kepesertaan yang bersangkutan dan informasi biaya tindakan *one day surgery*.
 - 3.3. **PIHAK PERTAMA** diminta untuk melakukan konfirmasi pada saat Peserta pulang dengan menginformasikan total biaya perawatan yang terjadi.

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) Tagihan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** segera setelah berakhirnya masa perawatan (sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perawatan) sesuai dengan biaya tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bilamana tagihan tidak diterima sampai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan diatas, maka tagihan tersebut sudah tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya tidak dapat melakukan tagihan secara langsung kepada Peserta atas klaim yang tidak dapat dibayarkan **PIHAK KEDUA** tersebut.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik dan lengkap setiap periode yang telah disepakati dengan laporan pengajuan klaim;
- (4) **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyelesaikan pembayaran atas tagihan tersebut sekurang -

Pihak I	Pihak II

kurangnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh dokumen penagihan diterima secara lengkap oleh **PIHAK KEDUA**.

- (5) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA**;
- (6) Tagihan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilengkapi dengan dokumen-dokumen penagihan sebagai berikut:
 - a. Rawat Inap:
 1. Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan alamat transfer (Nama Bank, Nomor Rekening Bank), sebagaimana tercantum dalam pasal ini.
 2. Kuitansi asli yang dibubuhi materai secukupnya
 3. Surat Pengantar Berobat dan resume medis **PIHAK PERTAMA**.
 4. Surat Pengantar Rawat (SPR) dari **PIHAK KEDUA**.
 5. Perincian Penagihan dan melampirkan copy kuitansi DP (*Down Payment*) atau kuitansi pembayaran dari peserta atas selisih biaya perawatan di tempat.
 6. Rekapitulasi/Faktur Penagihan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dengan memisahkan antara biaya konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
 - b. Rawat Jalan:
 1. Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan alamat transfer (Nama Bank, Nomor Rekening Bank), sebagaimana tercantum dalam pasal ini.
 2. Kuitansi asli yang dibubuhi materai secukupnya lengkap dengan perincian biaya dan copy resep/copy hasil pemeriksaan yang dilakukan.
 3. Struk Pengesahan (awal& akhir) pada sistem.
 4. Rekapitulasi/Faktur Penagihan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dengan memisahkan antara biaya konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**;
- (8) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
 Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
 Nomor Rekening : 368 - 3040700
 Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
 Cabang : KK Malang - Singosari
 Kode SWIFT/IBAN : CENAIIDJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO:

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
 Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
 Nomor Rekening : 144-0055533324
 Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
 Cabang : KK Malang - Blimbing
 Kode SWIFT/IBAN : BMRIIDJA

- (9) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Penambahan isi Perjanjian Kerjasama;
- (10) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional;
- (11) Dalam hal penagihan, **PIHAK PERTAMA** wajib untuk meminta nama jelas dan tanda tangan pasien/keluarga pasien untuk menandatangani (bukan paraf) perincian kuitansi yang akan dikirimkan ke **PIHAK KEDUA**, sehingga kuitansi tersebut dianggap telah diketahui oleh keluarga pasien.
- (12) Rekonsiliasi tagihan **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan 4 (empat) periode dalam setahun yaitu:
 - a. Pada akhir bulan April untuk periode Januari hingga Maret;
 - b. Pada akhir bulan Juli untuk periode April hingga Juni;
 - c. Pada akhir bulan Oktober untuk periode Juli hingga September; dan
 - d. Pada akhir bulan Januari untuk periode Oktober hingga Desember.
 Adapun jika sudah melewati batas waktu yang dimaksud tagihan tersebut tidak diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka tagihan tersebut tidak dapat diajukan kembali ke **PIHAK KEDUA**.
- (13) Peserta yang pembayarannya dijamin oleh **PIHAK KEDUA**, maka permintaan copy/legalisir kwitansi dan atau Resume Medis tidak dapat dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**. Peserta **PIHAK KEDUA** dipersilahkan untuk berhubungan langsung dengan **PIHAK KEDUA** mengingat dokumen asli telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (14) **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk setiap total tagihan biaya pelayanan kesehatan Peserta **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan buku tarif **PIHAK PERTAMA**
- (15) **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk memberikan potongan harga atau discount atas setiap biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 3% (Tiga persen) dari total tagihan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tarif yang berlaku dan telah disepakati kedua belah pihak.

PASAL 11 TARIF RUMAH SAKIT

1. Dalam hal terjadinya kenaikan atau penurunan tarif Rumah Sakit, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang perubahan tarif tersebut, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tarif tersebut berlaku.
2. Perubahan tarif tersebut apabila disetujui oleh **PIHAK KEDUA** hanya akan berlaku bagi peserta yang masuk Rumah Sakit setelah tanggal berlakunya tarif.
3. Bagi peserta yang sedang dalam perawatan, maka tarif baru akan diberlakukan segera setelah berlakunya tarif tersebut.
4. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa tarif dan biaya – biaya yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan standar umum yang berlaku juga bagi Pasien Umum di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II

PASAL 12

PENGUNAAN LAYANAN TPA

1. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan melalui email kepada **PIHAK PERTAMA** jika ada TPA Full Payor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk mengelola penjaminan dan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Perusahaan Peserta **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan langsung melakukan koordinasi perihal penjaminan dan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Perusahaan Peserta **PIHAK KEDUA** dengan TPA Full Payor yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** tetap melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait Penjaminan dan Pembayaran Tagihan untuk Pelayanan Kesehatan Peserta **PIHAK KEDUA** yang mempergunakan TPA Technology Only.

PASAL 13

PROGRAM JAGA MUTU DAN PENANGANAN KELUHAN

1. **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** akan mengadakan Program Jaga Mutu Eksternal:
 - 1.1. **PIHAK KEDUA** akan melakukan proses pemantauan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta oleh **PIHAK PERTAMA**, evaluasi akan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - 1.2. **PIHAK PERTAMA** merekam seluruh kegiatan pelayanan kesehatan kepada peserta dan **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan semua keterangan yang terdapat dalam Rekam medik termasuk Laporan Hasil Operasi bilamana diperlukan. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** memerlukan Laporan Medis termasuk Laporan Hasil Operasi dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa telah memiliki otorisasi penuh dari peserta **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Laporan Medis dan Informasi Medis lainnya dari **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** tidak akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan Laporan Medis tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk melakukan Program Jaga Mutu Internal Rumah Sakit guna tercapainya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi para peserta.

PASAL 14

TINDAKAN KECURANGAN (FRAUD)

1. Para Pihak sepakat untuk memerangi segala bentuk tindakan kecurangan (*Fraud*) yang terjadi dari waktu ke waktu, oleh karenanya pencegahan dan pemberantasan Fraud sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan komitmen dan tanggung jawab para Pihak;
2. Sehubungan dengan komitmen tersebut pada ayat 1 di atas, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membantu **PIHAK KEDUA** untuk memerangi Fraud, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemalsuan kwitansi pengibatan dan rincian pengobatan di rumah sakit;
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta **PIHAK PERTAMA** membuka historical transaksi biaya pengobatan pasien yang dirawat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** yang diduga melakukan tindakan fraud yang berkaitan dengan pemalsuan kwitansi untuk klaim asuransi **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan surat keterangan tambahan kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan sehubungan dengan proses investigasi asuransi dan pembuktian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap adanya dugaan Fraud dimaksud.

Pasal 15
KERAHASIAAN

- (1) Bahwa PARA PIHAK wajib melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik PARA PIHAK yang dipegang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Yang berhak menerima untuk pelepasan informasi medis **PIHAK KEDUA** yang dimaksud adalah pasien bertanggung adalah sesuai dengan yang ditercantum dalam kesepakatan pelayanan kesehatan;

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 17
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh **bencana alam seperti** gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, **bencana non alam seperti pandemi**, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban PARA PIHAK dan harus

Pihak I	Pihak II

- diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** telah terbukti melakukan malpraktik atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA** maka segala biaya kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaian dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan tariff atau biaya pelayanan Kesehatan tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 19 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. **PIHAK PERTAMA**

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
HP/WA : 0811 3507 164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Keuangan : Novi Ratnasari, SE
HP/WA : (0341) 458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

Pihak I	Pihak II

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Telp : 081315574065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Lidia Emilinda, S.Tr.Keb. M.MRS
HP/WA : 081315574065
Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com

Keuangan : Anita Fitria Sari, S.E
HP/WA : 085156001411
Email : keuanganrsphs@gmail.com

PIHAK KEDUA : PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk

Alamat : Komp. Permata Senayan Blok E No. 59-60 Jl. Tentara Pelajar
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12210
No. Telp : 150180
No. Fax. : (+6221) 57944226

Untuk Perhatian :
Head of Group Hospital & Surgical Claim Department : dr. Dian Paramita Kusumawardani
Head of Provider Relation Section : Ewin Primanto (ewin@mag.co.id)
Provider Relation : Ika Wulandari
(provider@mag.co.id)
Call Centre/Hotline 24 Jam : [150180](tel:150180) (hotline@mag.co.id)

**PASAL 20
LAIN - LAIN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

**PASAL 21
LAMPIRAN**

- (8) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (9) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan ang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

(10) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing – masing menerima satu rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA**

**PIHAK KEDUA,
PT.**

**ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA**

**.....
DIREKTUR**

NOTULEN RAPAT EVALUASI PKS EKSTERNAL

HARI / TANGGAL : 06 November 2024
PUKUL : 10.00
JENIS MEETING : Rapat Evaluasi PKS Eksternal
TEMPAT : R. Meeting Sekretariat

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : PKS Lippo General Insurance
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Asuransi membayarkan tagihan sesuai dengan tarif Rumah Sakit b. Selama berjalannya kerjasama tidak ada tagihan yang tertolak c. Terdapat 3 tagihan pasien yang masih belum terbayarkan di tahun 2023 dikarenakan perubahan sistem yang tidak diinformasikan, namun selama tahun 2024 seluruh tagihan di bayarkan tepat waktu d. PIC asuransi responsif dan informatif
	Rencana Tindak Lanjut -
2	Pokok Bahasan : PKS Asuransi Reliance
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Asuransi membayarkan tagihan sesuai dengan tarif Rumah Sakit b. Beberapa tagihan telat dibayarkan oleh pihak asuransi c. Untuk saat ini pembayaran masih berjalan dengan baik d. Asuransi Reliance serung digunakan oleh karyawan Perusahaan, seperti PT Nestle dan PT Charoen Pokphan yang sering rujuk ke rumah sakit
	Rencana Tindak Lanjut - Terkait pembayaran tagihan yang jatuh tempo , pihak rumah sakit akan memberlakukan denda kepada pihak asuransi sesuai dengan isi PKS yaitu 1%
3	Pokok Bahasan : PKS Asuransi Multi Artha Guna
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Terdapat banyak perturan saat melakukan tagihan dan ada 2 kode tagihan yang berbeda pembayaran sehingga terkadang menyulitkan proses penagihan yaitu tagihan melalui admedika atau ke pihak Asuransi b. Hingga saat ini asuransi tidak memiliki piutang kepada Rumah Sakit
	Rencana Tindak Lanjut -
4	Pokok Bahasan : PKS Equity Life Indonesia RI Cashless
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Asuransi membayarkan tagihan sesuai dengan tarif Rumah Sakit b. Selama berjalannya kerjasama tidak ada tagihan yang tertolak c. Pembayaran tepat waktu

	d. Asuransi tidak ada piutang ke Rumah Sakit
	Rencana Tindak Lanjut -
5	Pokok Bahasan : PKS PT Aneka Tuna Indonesia
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Rujukan pasien berjalan baik antara pihak perusahaan dan rumah sakit b. Pembayaran ditanggung oleh BPJS TK dan BPJS Kesehatan tidak ada kendala dalam tagihan pasien c. PIC perusahaan responsif dan informatif
	Rencana Tindak Lanjut -
6	Pokok Bahasan : PKS PT Antarmitra Sembada
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Untuk saat ini belum ada rujukan pasien dari perusahaan ke Rumah sakit b. Perusahaan tidak ada piutang kepada Rumah sakit
	Rencana Tindak Lanjut -

Pemimpin Rapat



(Lidia Emilinda, S.Tr.Keb, M.MRS)

Pasuruan, 05 November 2024

Notulis



(Agistia Zalfa Nasihah, S.M)

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

SUKOREJO



(dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS)

Lampiran I. Dokumentasi

